



Національний
Інститут Раку

Міністерство охорони здоров'я України
Національний інститут раку
Україна, 03022, м. Київ, вул. Ломоносова 33/43
www.unci.org.ua, e-mail: info@unci.org.ua

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової
документації № 028/о
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
14 лютого 2012 року № 110

КОНСУЛЬТАЦІЯ (МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТОМОГРАФІЇ)

1. Прізвище, ім'я, по батькові пацієнта: Жерліцина А. С.

2. Дата народження: 2 5 0 4 7 6

(число, місяць, рік)

3. Протокол дослідження: надано МРТ ОЧП, ОМТ з в/в к.п. від 24.08.2022; КТ ОГК, ОЧП, ОМТ з в/в к.п. від 23.08.2022

На КТ-сканах ОГК: Легені – без вогнищевої патології.

Медіастинальна лімфаденопатія не виявлено. Синуси вільні.

Трахея, головні бронхи прохідні. Серце не збільшене.

Вільної рідини в порожнині перикарду не виявлено.

Об'ємної патології в проекції м'яких тканин на рівні сканування не виявлено.

На КТ- та МР-сканах ОЧП: В паренхімі печінки визначаються вогнища наступних розмірів та локалізацій:

- S2 S3, 67x50мм (серія 2301000, скан 42);
- S8, 81x56мм (серія 2301000, скан 54);
- S8, 21x15мм (серія 2301000, скан 47);
- S1, 15x11мм (серія 2301000, скан 47);
- S5 S6 з частковим поширенням на S8 та S7, 170x110мм (серія 2301000, скан 32)

В проекції вогнищ визначається підвищення сигналу на DWI при b=400-800 з обмеженням дифузії на ADC map, при виконанні динамічної контрастної серії визначається гетерогенне накопичення парамагнетика, в центральних відділах вогнищ визначається зона кістозно-некротичної дегенерації – МР-картина відповідає "М".

Жовчні протоки не розширені. Жовчний міхур не змінений, конкрементів не містить.

В проекції лівих відділів черевної порожнини на рівні епігастрію між тілом шлунку, хвостом підшлункової залози та лівою ниркою визначається пухлинне утворення розмірами 49x46мм.

Підшлункова залоза – без вогнищевої патології, структурна, протока має нормальну ходу, діаметр просвіту.

Селезінка не змінена, контури її чіткі. Наднирники не змінені.

Нирки розташовані типово, диференціація паренхіми збережена, контури чіткі, сечоводи не розширені.

Заочеревинної лімфаденопатії, лімфаденопатії гепатодуоденальної зв'язки не виявлено.

На КТ- та МР-сканах ОМТ: Матка в антефлексії/антеверзії. Тіло матки – 47x48x50мм, зовнішній контур чіткий, порожнина не розширена, ендометрій – 3мм, сумарно сагітал. Визначаються ознаки дифузного аденоміозу; визначаються інтрамуральні міоми в стадії фіброзної дегенерації, розмірами до 23x19мм. Визначаються розширені судини параметрію.

По передньому контуру тіла матки визначається пухлинний вузол на ніжці, макс. аксіальними розмірами 86x62мм (серія 501000, скан 15), краніокаудальний розмір процесу – 63мм (серія 201000, скан 13). Структура утворення солідна, гетерогенна, з ознаками малігнізації, зовнішній контур чіткий.

Шийка матки – 26x34x24мм, МР-сигнал від шийки матки не змінений.

Лівий додаток – 30x26x19мм, неопластично змінений, зовнішній контур чіткий.

В проекції правого додатку – кістозне утворення розмірами 69x63x53мм, виповнене геморагічним вмістом.

Сечовий міхур нормального наповнення, стінки рівномірної товщини.

Лімфаденопатії малого тазу не виявлено.

Пряма кишка – без особливостей.

МР-сигнал від кісток не змінений.

ВИСНОВОК:

Радіологічні ознаки саркоми тіла матки (вузол на ніжці). «М»-ураження лівого додатку. «М»-ураження печінки. Саркоматоз черевної порожнини (солітарний вузол в проекції лівих відділів епігастрію). Ендометріюїдна кіста правого додатку.

Лікар-рентгенолог

Ганч О. В.

Лікар-рентгенолог, к.мед. н.

Гаврилюк О. М.
(П.І.Б.) (підпис, МП)

25.08.2022

Міністерство Охорони Здоров'я України
ТОВ "ДОКТОР ФІЛІН"
Україна, м. Київ., вул. К.Малевича, 86-Г; пр-т.Л.Гузара, 3, к-5., вул. Відпочинку, 11
тел.: 237-13-43, 095-5576633, 098-5576633
Ліц. МОЗ України АБ№539367



ДОКТОР ФІЛІН
ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР ТОМОГРАФІЇ

Медицина документація
Форма первинної облікової документації № 028/с
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
14.02.12р. №110

ПРОТОКОЛ ОПИСУ КОМП'ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ

Назва обстеження:

КТ органів грудної порожнини, органів черевної порожнини з заочеревинним простором та органами малого тазу до та з контрастуванням

Контрастна речовина Омніпак 350 мг йоду/мл, об'єм 100 мл. Променеве навантаження 2163 mGy*см.кв

Реакція на контрастну речовину не було

ПІБ пацієнта **Жерлиця Анастасія Станіславівна** ІД Пацієнта 74595

Дата народження **25.04.1976** Дата обстеження **23.08.2022**

ПІБ оператора КТ який провів обстеження Геращенко Оксана Василівна

Протокол опису:

Шийні, над- та підключичні лімфовузли не збільшені.

Аксиллярні лімфовузли не збільшені.

Щитоподібна залоза не збільшена, однорідно накопичує контраст.

Легені рівномірно пневматизовані, інфільтративних ділянок не виявлено, нечисленні дрібні вузлики до 3 мм.

Судинний малюнок рівномірно розподілений. Трахея та головні, часткові та сегментарні бронхи прохідні. Вільної рідини в плевральних порожнинах не виявлено.

Серце не збільшене, порожнини рівномірно контрастовані. В перикарді вільна рідина не візуалізується. Висхідна та низхідна аорта, цефалічні стовбури без змін. Легеневі артерії, ВПВ та НПВ не розширені, без змін. Внутрішньогрудні лімфатичні вузли не збільшені. Стравохід не розширений, стінки його не потовщені. Діафрагма без особливостей.

Вільної рідини в черевній порожнині не виявлено. Кардія, шлунок, дванадцятипала кишка, тонка та товста кишка не розширені, без достовірних уражень.

Печінка збільшена, ККР 198 мм, білобарно візуалізуються одиничні утворення, неоднорідної структури, з некрозом в центрі, по периферії виражена васкуляризація. Часткові печінкові вени, ліва ворітна вена без змін, права ворітна вена не візуалізується. Внутрішньопечінкові жовчні протоки: локальне розширення в Sg3, на іншому проміжку печінки не розширені. В гепатодуоденальній зв'язці: ворітна вена не розширена. Хоledох не розширений. Жовчний міхур не візуалізується.

Підшлункова залоза компримована, паренхіма контрастується рівномірно. Протока залози не розширена. Вище хвоста залози візуалізується вузлове утворення неоднорідної щільності, з вираженою васкуляризацією по периферії (неоангіогенез), розміром 51x46мм (більш ймовірно не пов'язане з підшлунковою залозою, компримує її ззовні, тісно прилягає до шлунку, петель голодної кишки).

Селезінка не збільшена, структура однорідна. Селезінкова вена не розширена. Лімфатичні вузли воріт селезінки не збільшені.

Наднирки симетричні не збільшені.

Нирки: права зміщена вниз збільшеною печінкою, ліва розташована в типовому місці. Паренхіма обох нирок не потоншена. Кортико-медулярна диференціація не порушена. ЧМС, сечоводи не розширені. Конкременти в мисках, сечоводах відсутні. Екскреторна функція не порушена. Магістральні судини заочеревинного простору без змін. Лімфатичні вузли заочеревинного простору: нечисленні парааортальні до 8 мм.

Сечовий міхур - стінки не потовщені, внутрішньопросвітних утворень немає.

В малому тазу: вище сечового міхура, попереду від дна матки- вузлове гетерогенне утворення, з вираженою васкуляризацією (неоангіогенез), з одиничними дрібними кальцинатами, розміром 93x63 мм, з некрозом, виключити або підтвердити зв'язок з маткою важко; вище та правіше матки- округле утворення 67x57 мм, без явного накопичення контрасту (геморагічна кіста правого яєчника?).

Матка не збільшена, по правій поверхні тіла вузол 37x27 мм (ймовірно субсерозна міома). Яєчники -диференціація утруднена. Невелика кількість рідини в тазу.

Лімфатичні вузли черевної порожнини, малої миски, пахові не збільшені.

В кістках без остеолітичних, склеротичних вогнищ.

Заключення:

Одиничні новоутворення в тазу, в черевній порожнині-над хвостом підшлункової залози (диференціювати з Gist). Мтс в печінку, білобарно.

Одиничні дрібні вузлики в легенях- спостереження в динаміці.

Міома матки, геморагічна кіста ? правого яєчника.

Рекомендації:

Консультація онколога. За клінічною потребою- МРТ черевної порожнини, тазу. Гістологічна верифікація.

Дата: 23.08.2022

Лікар-рентгенолог:

Целованська Лія Вікторівна

(підпис)

М.П.

*Дане заключення не є клінічним діагнозом. Даний документ має бути інтерпретований лікуючим лікарем у відповідності з клінічною картиною.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пацієнт: Жерліцина Анастасія Станіславівна

Лаб. № замовлення 993153113

Дата народж. 25.04.1976

Код замовлення:

Стать: Жіноча

Дата замовлення: 25.08.2022 11:29

Коментарі: День менструального циклу: 27

ID: 4821

Період репродуктивної функції: Репродуктивний

Назва дослідження	Результат	Одиниці вимірювання	Референтні значення	Коментарі
Загальні антитіла до <i>Treponema pallidum</i> Первинна проба: венозна кров	0.35 негативний	Індекс	< 0,9	<0.9 негативний 0.9-1.1 сумнівний >1.1 позитивний
Гепатит В HBsAg Первинна проба: венозна кров	0.19 негативний	S/CO	< 1,0	<1,0 негативний >1,0 позитивний
Антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV) Первинна проба: венозна кров	0.10 негативний	Індекс	< 0.8	<0.8 негативний 0.8 - 1.0 сумнівний >1.0 позитивний
Глюкоза (кількісний) Первинна проба: венозна кров	3.5*	ммоль/л	4,1 - 6	натщесерце
Загальний білок Первинна проба: венозна кров	64	г/л	57 - 82	
Білірубін загальний Первинна проба: венозна кров	11.3	мкмоль/л	5 - 21	
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) Первинна проба: венозна кров	26	Од/л	4 - 31	
Аспартатамінотрансфераза Первинна проба: венозна кров	20	Од/л	4 - 31	
Лужна фосфатаза загальна Первинна проба: венозна кров	238*	Од/л	35 - 104	
Креатинін Первинна проба: венозна кров	70	мкмоль/л	48 - 77	
Сечовина Первинна проба: венозна кров	5.1	ммоль/л	1,7 - 8,3	
Альбумінопротеїн (АФП) Первинна проба: венозна кров	1.80	МО/мл	< 8,1	

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Пацієнт: Жерліцина Анастасія Станіславівна

№ зам.: 993153113

Дата друку: 25.08.2022 18:00

с.1 з 2

Шановний клієнте! Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень, зверніться, будь ласка, до лікаря. Шановний лікарю! Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань. Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії КОЗУ МЗ № 014752 від 27.03.2020



Гарантія точності та достовірності результатів досліджень

Атестат про акредитацію відповідно до ДСТУ EN ISO 15189:2015 (EN ISO 15189: 2012, IDT) № 30001 від 04.09.2020 р.

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 6а
www.dila.ua dila.ua

Інформаційно-сервісна служба 0 800 21 78 87

Шановний лікарю!
Експерти ДІЛА надають інформаційну підтримку щодо трактування результатів лабораторного дослідження та інших професійних питань.

Шановний клієнте!
Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Для коректної інтерпретації результатів досліджень зверніться, будь ласка, до лікаря.

Ліцензія МОЗ України АД №071280 від 22.11.2012 г. ТОВ «ДІЛА» сертифіковано згідно вимог міжнародного стандарту ISO 9001. Акредитаційний сертифікат вищої категорії МОЗ № 014392 від 27.03.2020

Раково-ембріональний антиген
Первинна проба: венозна кров

7.03*

нг/мл

< 4,8

Коагулограма на автоматичному аналізаторі

Первинна проба: венозна кров

Міжнародне нормалізаційне співвідношення (INR)

1.11

0.85 - 1.2

Процент протромбіну за Квіком

80.0

%

> 70

Протромбіновий час

11.7

с

9.6 - 11.8

Активований Частковий

Тромбопластиновий Час (АЧТЧ)

31.4

с

21,6 - 32,5

Фібриноген

584*

мг/дл

180 - 350

Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: CA 125, HE-4)

Первинна проба: венозна кров

Онкомаркер яєчників CA 125

93.60*

Од/мл

< 35

Ранній онкомаркер яєчників HE-4

77.9*

пмоль/л

< 70

Індекс ROMA

20.6*

%

< 7.4

Репродуктивний вік
<7.4 - низький ризик
епітеліального РЯ
>7.4 - високий ризик
епітеліального РЯ

Постменопауза
<25.3 - низький ризик
епітеліального РЯ
>25.3 - високий ризик
епітеліального РЯ

Відповідальна особа

Завідувач Лабораторії загальноклінічних досліджень Несененко О.В.

символом * позначаються результати, що виходять за межі референтних значень

Пациєнт: Жерлщина Анастасія Станіславівна

№ зам.: 993153113

Дата друку: 25.08.2022 18:00

с.2 з 2